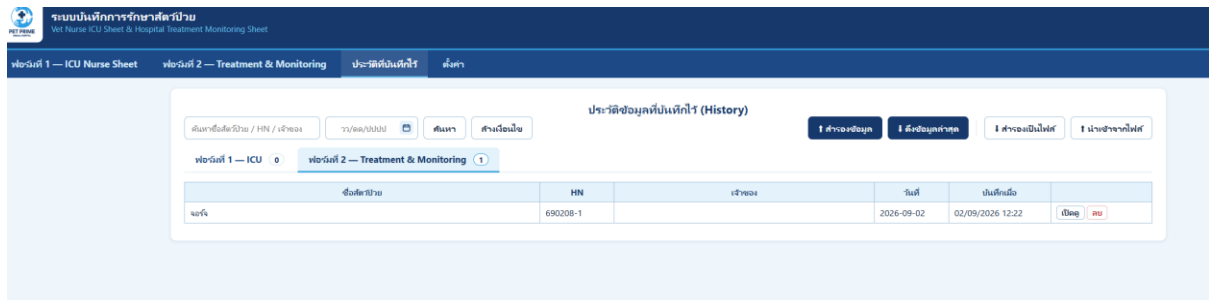


ทำใบแผน CCU

> กรณีสัตว์ป่วยตัวนั้น มีแผน CCU อยู่แล้ว หรือไม่แน่ใจว่าในเซฟเวอร์รวม มีแผนของสัตว์ตัวนี้อยู่มั้ย

1. เลือกรุ่น “ประวัติที่บันทึกไว้” แล้วกด “ดึงข้อมูลล่าสุด”

เพื่อดึงแผน CCU ที่ถูกบันทึกไว้ในเซฟเวอร์รวม มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่

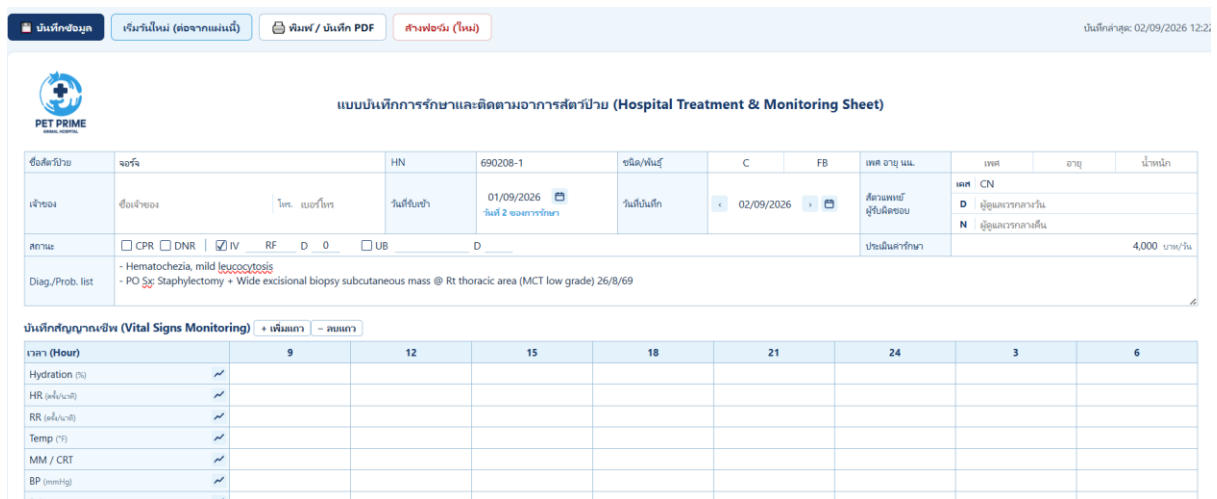


2. ถ้ามีข้อมูล ให้ทำต่อจากแผนเดิม กด “เปิด”

- เปิดไฟล์แล้วคัดลอกหรือแก้ไขต่างๆ กรอกรายละเอียดเรียบร้อย แล้วกด “บันทึกข้อมูล”

- ข้อมูลจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่บันทึก แต่ยังไม่อยู่ในเซฟเวอร์รวมที่ลิงก์กับคอมพิวเตอร์เครื่อง

- กด “พิมพ์” เพื่อพิมพ์แผนที่เสร็จแล้วออกมาใช้



3. ทำการบันทึกข้อมูลไปเซฟเวอร์รวมของทุกเครื่องโดยเลือกรุ่น “ประวัติที่บันทึก”

จะแสดงไฟล์ว่าเครื่องนี้บันทึกประวัติตัวไหนไว้บ้าง

4. เลือก “สำรองข้อมูล”

เพื่อเซฟไฟล์ที่บันทึกในคอมไปยังเซฟเวอร์รวม ที่คอมทุกเครื่องเห็นเหมือนกัน เมื่อกด“สำรวจข้อมูล”แล้วใบแพลนนี้จะสามารถดูได้จากคอมทุกเครื่อง

ชื่อสัตว์ป่วย	HN	เจ้าของ	วันที่	บันทึกเมื่อ	บันทึกโดย
จอร์จ	690208-1	เจ้าของ	2026-09-02	02/09/2026 12:22	บันทึก

> กรณีสัตว์ป่วยตัวนั้นยังไม่มีเคมีแพลน CCU

1.เลือกแบบฟอร์ม ถ้าพยาบาลใช้ฟอร์มที่ 1 หมอใช้ฟอร์มที่ 2

Vital Signs (รายการ)	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00	00:00	03:00	06:00
HR / RR (ครั้ง/ชม)								
Temp (°C)								
MM								
BP (mmHg)								
Vomit (ครั้ง/ชม)								
Fecal score (ครั้ง/ชม)								
Urination / UOP (ครั้ง/ชม)								

2.กรอกรายละเอียดเรียบร้อย แล้วกด “บันทึกข้อมูล”

ข้อมูลจะอยู่ในคอมเครื่องที่บันทึก แต่ยังไม่อยู่ในเซฟเวอร์ที่ลิงค์กับคอมทุกเครื่อง


แบบบันทึกการรักษาและติดตามอาการสัตว์ป่วย (Hospital Treatment & Monitoring Sheet)

ชื่อสัตว์ป่วย	จอร์จ	HN	690208-1	ชนิด/พันธุ์	C	FB	เพศ อายุ นน.	เพศ	อายุ	น้ำหนัก
เจ้าของ	ชื่อเจ้าของ โทมัส เบิร์ทโท	วันที่รับเข้า	01/09/2026 วันที่ 2 ของการรักษา	วันที่บันทึก	02/09/2026	สถานะแพทย์ ผู้รับผิดชอบ	เดส CN	D	อยู่ดูแลเวลากลางวัน	
สถานะ	☐ CPR ☐ DNR ☒ IV RF D 0 ☐ UB D						ประเมินค่ารักษา		4,000 บาท/วัน	
Diag./Prob. list	- Hematochezia, mild (02/09/2026) - PO Staphylectomy + Wide excisional biopsy subcutaneous mass @ Rt thoracic area (MCT low grade) 26/8/69									

บันทึกสัญญาณชีพ (Vital Signs Monitoring) + เพิ่มแถว - ลบแถว

เวลา (Hour)	9	12	15	18	21	24	3	6
Hydration (%)	✓							
HR (ส่น/วินาที)	✓							
RR (ส่น/วินาที)	✓							
Temp (°C)	✓							
MM / CRT	✓							
BP (mmHg)	✓							

3. ทำการบันทึกข้อมูลไปเซฟเวอร์รวมของทุกเครื่องโดยเลือกหน้า “ประวัติที่บันทึก”

จะแสดงว่าเครื่องนี้บันทึกประวัติตัวไหนไว้บ้าง

4. เลือก “สำรองข้อมูล”

เพื่อเซฟไฟล์ที่บันทึกในคอมไปยังเซฟเวอร์รวม ที่คอมทุกเครื่องเห็นเหมือนกัน เมื่อกด “สำรองข้อมูล” แล้วใบแพลนนี้จะสามารถดูได้จากคอมทุกเครื่อง


ระบบบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย
 Vet Nurse ICU Sheet & Hospital Treatment Monitoring Sheet

ฟอร์มที่ 1 — ICU Nurse Sheet
 ฟอร์มที่ 2 — Treatment & Monitoring
 ประวัติสัตว์ที่บันทึก
 ค้นหา

ประวัติข้อมูลที่บันทึกไว้ (History)

ฟอร์มที่ 1 — ICU 0
 ฟอร์มที่ 2 — Treatment & Monitoring 1

ชื่อสัตว์ป่วย	HN	เจ้าของ	วันที่	บันทึกเมื่อ	บันทึกโดย
จอร์จ	690208-1		2026-09-02	02/09/2026 12:22	บันทึก

Note : ไฟล์ของสัตว์ในเซฟเวอร์รวม อิงตามเครื่องที่กด “สำรองข้อมูล” ล่าสุด ดังนั้น เพื่อป้องกันเซฟทับไฟล์ที่ล่าสุดกว่า ไฟล์ที่มีในคอมที่ใช้อยู่ แนะนำให้ก่อนทำแพลนทุกครั้ง กด “ดึงข้อมูลล่าสุด” เพื่อดึงไฟล์ล่าสุดจากเซฟเวอร์เข้ามาที่เครื่องคอมที่ใช้อยู่เสมอ

วิธีการทำแผน

1. แผนหมอ



แบบบันทึกการรักษาและติดตามอาการสัตว์ป่วย (Hospital Treatment & Monitoring Sheet)

ชื่อสัตว์ป่วย	จอร์จ	HN	690208-1	ชนิด/พันธุ์	C	FB	เพศ อายุ นม	M	4 Y	14.95 kg
เจ้าของ	อรรถพร	โทร. 0818111861	วันที่รับเข้า	01/09/2026	วันที่บันทึก	02/09/2026	สัปดาห์ที่ ผู้รับเลี้ยง	เพศ	CN	
								D	ผู้ดูแลเวลากลางวัน	
								N	ผู้ดูแลเวลากลางคืน	
สถานะ	☒ CPR ☐ DNR ☒ IV RF D 0 ☐ UB D						ประเมินสภาพ			4,000 บาท/วัน
Diag./Prob. list	- Hematochezia, mild leukocytosis - PO Stx Staphylectomy + Wide excisional biopsy subcutaneous mass @ Rt thoracic area (MCT low grade) 26/8/69									

- ช่อง “บันทึกสัญญาณชีพ”

ไฮโดรต์ด้วยปากกว่าจะต้องมีนิเตอร์ค่าอะไรบ้าง และเวลาไหนบ้าง (ทำตอนปรีนกระดากออกมาแล้ว)

ค่า urination/defication มอนิเตอร์ทุก 3 ชั่วโมง ตามตาราง กรณีต้องพาเดินให้แสงเล็บต่อด้านหลังคำว่า urination/defication

ค่าอื่นๆเลือกไฮโดรต์เองตามตาราง ขึ้นต่ำในการมอนิเตอร์คือทุก 12 ชั่วโมง (9.00 ,21.00) เช่น hydration, HR, RR, temp, mm/CRT หากมีค่าอื่นๆเพิ่มแถวได้ เช่น พลิกตัว ทุก 3 ชั่วโมง

บันทึกสัญญาณชีพ (Vital Signs Monitoring)

+ เพิ่มแถว - ลบแถว

เวลา (Hour)	9	12	15	18	21
Hydration (%)	~				
HR (ครั้ง/นาที)	~				
RR (ครั้ง/นาที)	~				
Temp (°F)	~				
MM / CRT	~				
BP (mmHg)	~				
Pain score (0-4)	~	▼	▼	▼	▼
Mentation (Alert/Depress/Obtund/Stupor)	~	▼	▼	▼	▼
Vomit	~				
Urination (Y/N, UOP)	~				
Defecation (Y/N, FS)	~				

- ช่อง “บันทึกการให้ยา/หัตถการ”

เรียงลำดับ ยาฉีด > ยากิน > หัตถการ โดยเว้นบรรทัดแต่ละหมวดหมู่ หมวดหมู่ละ 1 บรรทัด และกดเลือกเวลา จะมีช่องสี่เหลี่ยมขึ้นที่เวลาที่ต้องให้ยา/ทำหัตถการนั้นๆ

ยาฉีดเริ่ม 9.00 น. ยากินเริ่ม 6.00 น. (อิงตามเวลาอาหาร) แผนหัตถการรอบเช้าเริ่ม 9.00น. เช่น

บันทึกการให้ยา/หัตถการ (Treatment / Medication Administration Record)

+ เพิ่มแถว

- ลบแถว

Treatment	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prevomax 1.5 ml SC ×	☐								
Omeprazole 3.8 ml IV									
Metronidazole 15 ml 30									
Buprenorphine 1 ml SC									
Treatment									
baytril 1 tab PO	☐								
Gaba (100) 1+1/2 t PO	☐								
Treatment									
เช็ดหู				☐					

- แพลนชนิดและเวลาป้อนอาหาร โดยเวลาป้อนเริ่มต้นที่ 6.00 น. เช่น กิน 2 เวลา > 6.00 , 18.00 น. กิน 3 เวลา 6.00, 14.00, 22.00 น

Fluid / Rate / Route

+ เพิ่มแถว

- ลบแถว

Fluid /Rate/Route	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Acetar/ 30 / IV																	
Fluid /Rate/Route																	
Fluid /Rate/Route																	

บันทึกการป้อนอาหาร

เวลาป้อน	6.00	18.00			
ชนิดอาหาร / ปริมาณที่ให้ g/ml	Analler เม็ด 20-25 กรัมแช่น้ำ 2 มื้อ/วัน	total 40-50 กรัม/วัน			
ปริมาณที่กิน g/ml					

แผนการรักษา

- 3/9/69 Wd แผลผ่าตัด
- ตัดไหม Next 5/9/69 (แต่ถ้าตำแหน่งไหนยังไม่แห้ง รอ 14 วันค่อยตัดได้ค่ะ) + recheck CBC +/- Rx atopica ถึงวันนัดอาจารย์มีนา(หรือจะลองให้ทานก่อนสัก 5 วันก็ได้แล้วค่อยให้ตามรับยาเพิ่ม) + ผ่ากแผลผ่าตัดเพื่อลด
กว่านั้น)
- 8/9/69 F/u diarhea q7d +/- RX Baytril, Fibor, Florgut ต่อ

2. แพลนพยาบาล คัดลอกจากแพลนหมอ

-A. vital sign ไรต์ไลต์ค่าและเวลาที่ต้องมอนิเตอร์ตามแพลนหมอ

-B. และ C. ลอกตามแพลนหมอ ช่อง “บันทึกการให้ยา/หัตถการ” แต่คัดลอกแค่ยากินและหัตถการ ไม่ต้องลอกยาฉีด

A. Vital Signs Monitoring

+ เพิ่มแถว - ลบแถว

Vital Signs (เวลา)		09:00	12:00	15:00
HR / RR (ครั้ง/นาที)				
Temp (°F)				
MM				
BP (ตามต้น)				
Vomit (อาเจียน)				
Fecal score (อุจจาระ)				
Urination / UOP (ปัสสาวะ)				
รายการเพิ่มเติม				
รายการเพิ่มเติม				

B. Nursing Care Checklist

+ เพิ่มแถว - ลบแถว

Nursing Care (เวลา)	06:00	09:00	12:00
เช็ดหู		☐	
รายการพยาบาล (Nursing care)			
รายการพยาบาล (Nursing care)			
รายการพยาบาล (Nursing care)			
รายการพยาบาล (Nursing care)			
รายการพยาบาล (Nursing care)			

C. ยาที่ต้องป้อน / ให้ (Medication Checklist)

+ เพิ่มแถว - ลบแถว

ชื่อยา (Drug)	ขนาด (Dose)	ทาง (Route)	06:00	09:00	12:00
baytril	1 t	PO	☐		
Gaba (100)	1+1/2 t	PO	☐		
ชื่อยา (Drug)	ขนาด (Dose)	ทาง (Ro			
ชื่อยา (Drug)	ขนาด (Dose)	ทาง (Ro			
ชื่อยา (Drug)	ขนาด (Dose)	ทาง (Ro			
ชื่อยา (Drug)	ขนาด (Dose)	ทาง (Ro			
ชื่อยา (Drug)	ขนาด (Dose)	ทาง (Ro			
ชื่อยา (Drug)	ขนาด (Dose)	ทาง (Ro			

-D.ลอกตามแผนหมอ

D. บันทึกการป้อนอาหาร (Feeding Record)

Feeding (เวลา)	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00
ชนิดอาหาร (Food type)	Analler เน็ด				Analler เน็ด
ปริมาณที่ให้ (Offered g/ml)	20-25 กรัมแช่น้ำ 2 มื้อ/วัน				20-25 กรัมแช่น้ำ 2 มื้อ/วัน
ปริมาณที่กิน (Consumed g/ml)					
วิธีป้อน (Voluntary/Assist/Syringe/Tube)					

